

子宫绒毛膜癌致腹腔大出血死亡 1 例

段祎杰¹, 王朝晖², 李上勋¹, 王 昊¹, 邢景军¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学 同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 武汉市公安局 洪山区分局刑侦大队, 湖北 武汉 430070)

关键词: 法医病理学; 绒毛膜癌; 腹腔积血

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2011.04.022

文章编号: 1004-5619(2011)04-0310-02

1 案 例

1.1 简要案情

某女, 43 岁, 某日因“上腹不适 2 周, 胸闷、气促 1 周”入院。查体: 左下肺呼吸音消失, 左中上肺及右肺呼吸音粗, 无啰音; 左上腹及下腹部压痛, 无反跳痛。影像学检查: 左下肺炎症并左侧少量胸腔积液, 慢性胃炎并食管反流。既往史: 1 年前曾因葡萄胎住院治疗, 后好转。入院诊断: 左下肺炎, 左侧胸腔积液(胸膜炎?), 慢性胃炎, 食管反流。入院第 9 天复查胸片, 报告示“支气管炎, 双下肺感染及左侧少量胸腔积液”。第 10 天诉偶有胸痛不适, CT 报告示两肺感染性病变并两侧胸膜增厚(图 1)。第 11 天患者下腹部压痛, 无反跳痛。第 12 天腹部 B 超报告示子宫占位性病变(性质待定); 尿 HCG 结果阴性。妇产科会诊考虑“子宫肌瘤, 绒毛膜癌?”。第 13 天突发痛苦样呻吟, 叹息样呼吸, 血压测不到, 经抢救无效死亡。

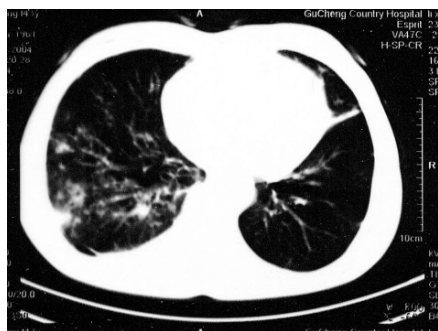


图 1 肺部 CT 所见

层出血, 子宫肌层及宫腔内见多个灰白色肿块, 其中最大为 6.0 cm×6.0 cm×4.5 cm。右侧输卵管增粗, 内见大小不一的肿块。镜下见子宫肌层及宫腔内肿块有大量癌细胞, 癌组织由高度异型增生的细胞滋养层细胞和合体滋养层细胞构成, 癌巢及转移灶中央见明显的出血及坏死, 未见绒毛结构, 部分血管腔内可见癌栓。子宫破裂口处见癌组织浸润子宫全层并穿透浆膜层。左、右侧胸腔积液量分别为 300、1 000 mL, 呈淡黄色。双肺表面及切面散在粟粒至绿豆大小的灰白色结节, 质实, 以双肺底部多见, 切面见片状出血, 双侧肺动脉及其分支血管见癌栓形成。镜下部分肺泡腔内可见大量红细胞或较多的巨噬细胞, 部分呈灶性肺不张及代偿性肺气肿, 肺内可见结节状转移癌, 血管腔内癌栓形成(图 3), 部分癌组织出血、坏死(图 4), 癌组织由高度异型增生的细胞滋养层细胞及合体滋养层细胞构成, 未见绒毛结构。心包腔淡黄色积液约 60 mL。其余各器官血管空虚, 呈贫血状。

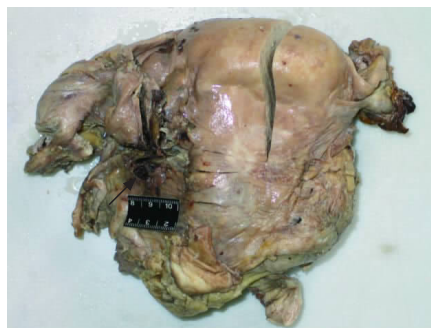


图 2 子宫右侧破裂口

1.2 尸体检验

尸体解剖: 腹腔积血 3 000 mL 并伴有凝血块。子宫及附件明显增大, 质量 510 g, 子宫大小 14.0 cm×12.0 cm×5.0 cm, 质硬, 外形不规则, 呈结节状突起, 右侧宫体见一 1.0 cm×1.0 cm 破裂口(图 2), 周围子宫肌

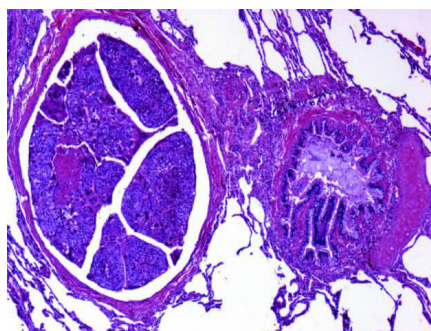


图 3 肺血管腔癌栓 HE×40

作者简介: 段祎杰(1986—), 男, 湖北武汉人, 博士研究生, 主要从事法医病理学研究; E-mail: gerichtsarzt@gmail.com
通信作者: 周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究; E-mail: yiwuhedi@sina.com

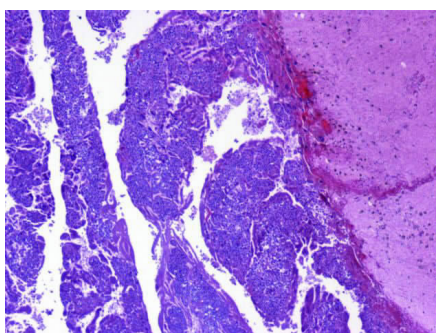


图4 癌组织出血、坏死 HE×40

法医病理学诊断:子宫绒毛膜癌破裂,腹腔积血;绒毛膜癌弥散性肺转移;胸腔积液。

死亡原因:子宫绒毛膜癌浸润生长,穿透子宫壁并破裂,导致失血性休克死亡。

2 讨论

绒毛膜癌(choriocarcinoma)简称绒癌,是一种高度恶性的肿瘤,其特点是滋养层细胞失去了原来绒毛或葡萄胎的结构,散在地侵入子宫肌层,不仅造成严重的局部破坏,而且常转移至其他器官造成严重的损害。绝大多数的绒癌继发于正常或不正常的妊娠之后,称“继发性绒癌”或“妊娠性绒癌”,主要发生于育龄妇女。

绒癌在临床上常见症状为葡萄胎、流产或足月产后的阴道持续不规则出血,量多少不定^[1]。研究^[2]表明绒癌继发于完全性葡萄胎、流产、正常妊娠、宫外孕的比例分别为50%、25%、22.5%及2.5%,完全性葡萄胎进展为绒癌的风险为2%~3%,而部分性葡萄胎进展为绒癌的危险性则较低。绒癌以出血性坏死外观为病理学特点,常广泛侵犯宫壁肌层。镜下由分化不良的细胞滋养层细胞及合体滋养层细胞构成,癌细胞混合排列成巢状或条索状,常见核分裂象,不形成绒毛和水泡状结构。本例死者为育龄妇女,发病1年前有过葡萄胎病史,符合绒癌发病特点,且病理变化也符合绒癌病理特点。

绒癌可转移至几乎所有器官,但肺、阴道、肝、脑等为绒癌转移的最常见器官。绒癌早期的症状较少,往往不易被发现,患者常因转移瘤的症状而就诊,故绒癌易被漏诊或误诊,偶有少数病例,原发灶已经消失,而仅见继发转移瘤^[1]。因此妊娠结束后6周、持续异常阴道出血的患者均应进行血清HCG检测,以排

除再次妊娠或滋养细胞疾病,且所有育龄妇女出现原发病灶不明的转移癌时,也应当考虑绒毛膜癌的可能^[3]。

本例有明确的葡萄胎病史及肺部转移灶的临床症状和体征,应当首先考虑绒癌的可能,但因患者表现为肺部症状,而被误诊为“左下肺炎,左侧胸腔积液(胸膜炎?),慢性胃炎,食管反流”,在诊断上存在一定失误。本例死者于死亡前一天进行尿HCG检测,结果为阴性,在一定程度上影响了绒癌的诊断。有报道^[4],HCG分子的微观不均质性所致的免疫活性差异、反应体系pH值及钩状效应等因素,可以导致尿HCG检测结果呈假阴性。因此,对于高度怀疑绒癌的患者,不应仅凭一次尿HCG阴性结果而排除绒癌可能,而需要进行血清HCG定量检测或重复检验,并结合其他的诊疗手段进行确诊^[5]。

法医病理学鉴定中应注意:(1)常规检验子宫及附件,对于育龄妇女有腹腔出血时,尤应注意排除宫外孕、绒癌等;(2)尸检时应提取全血、分离血清或留取尿液,检测HCG,这对于判断生前是否有误诊、漏诊等有较大帮助;(3)怀疑绒癌时,应仔细检验,寻找肺、脑、肝、脾等器官转移灶的证据;(4)全面调阅病历,尤其是影像学资料,在医疗纠纷鉴定中非常关键。本例复阅胸部CT片,见右肺大小不等的结节状影,而院方未考虑转移性病灶的可能性,应属漏诊。

参考文献:

- [1] 连利娟. 林巧稚妇科肿瘤学[M]. 第4版. 北京:人民卫生出版社,2006:764-765.
- [2] Buza N, Hui P. Gestational trophoblastic disease: histopathological diagnosis in the molecular era[J]. Diagnostic Histopathology, 2010, 16(11):526-537.
- [3] Soper JT, Mutch DG, Schink JC. Diagnosis and treatment of gestational trophoblastic disease: ACOG Practice Bulletin No. 53[J]. Gynecol Oncol, 2004, 93(3):575-585.
- [4] Olaniyan OB, Momoh JA. Negative urine hCG in choriocarcinoma[J]. Int J Gynaecol Obstet, 2007, 98(1):59-60.
- [5] Ajufo II, Lindow SW, Canty SH. Choriocarcinoma with markedly elevated serum hCG levels and negative urine hCG levels[J]. J Obstet Gynaecol, 2006, 26(1):83-85.

(收稿日期:2011-03-29)

(本文编辑:张建华)